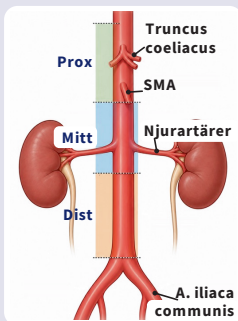


## ÖVERSIKT

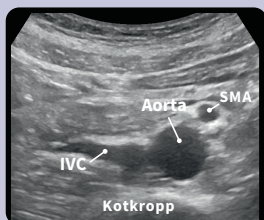
**Bukaorta** · aneurysm?**Läge:** bukprob, ryggläge, böjda ben.

Tvärsnitt under xifoid, markör åt patientens höger, djup 15 cm.

**Svep:** hela aorta från truncus coeliacus till bifurkationen i tvärsnitt, sedan i längsaxel. Följ iliaca en bit.

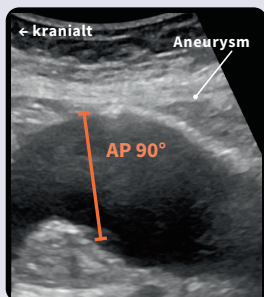
- Truncus coeliacus eller SMA i bild = tillräckligt proximalt.
- Infrarenalt = vanligaste aneurysmläget.

## TVÄRSNITT

**Hitta aorta****Kotkroppen** längst ner: ljus, konvex, med skugga. **Aorta** rund, tjockväggig, pulserar, framför kotkroppen till vänster (skärmens höger). **IVC** till höger: tunn vägg, plattas av tryck och andning.

- Tarmgas: tryck stadigt, gå lateralt eller sidoläge. Obes: sänk frekvensen.

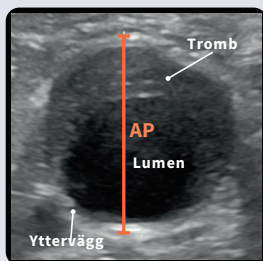
## LÄNGSAXEL

**Längsaxel**

Vrid 90° medurs, markör kranialt. Kärlet ska löpa ut i båda bildkanter; glid i sidled till den bredaste delen.

- Mät AP 90° mot längdaxeln. Snitt vid sidan om kärlets mitt underskattar.

**Frågor:** aorta  $\geq 30$  mm? Iliaca  $\geq 15$  mm? Dubbelt lumen? **Ej hela aorta sedd = ej bedömbär.**



**Diameter** · yttervägg till yttervägg  
AP-mått i tvärsnitt där aorta är störst, vinkelrätt mot kärlet. **Tromben ingår:** mät inte bara det svarta lumen. Sänk gain så att lumen är svart. Mät om när diametern ökar eller djupet ändras.

- Vid osäkerhet: flera mätningar, kontrollera i längsaxel.

### Gränser

**Aorta:** <30 mm normalt · **≥30 mm aneurysm** · ≥50 mm (kvinnor) / ≥55 mm (män): elektiv operationsbedömning.

**Iliaca communis:** <15 mm normalt. **Dubbelt lumen eller flik:** dissektion – akut även vid normal diameter.

### Akut

Aneurysm + buk-, flank- eller ryggsmärta, synkope eller chock: **kärlkirurg direkt, akut DT-angiografi.** Litet aneurysm utesluter inte ruptur, och POCUS kan inte utesluta retroperitoneal blödning.

**Bifynd utan symtom:** spara bilder, remiss enligt lokal rutin.

### Fallgropar

IVC för aorta: tunn vägg, droppformad, komprimerbar. Lumen i stället för yttervägg vid tromb. Snett snitt över- eller underskattar. Tarmgas och obesitas: hela aorta måste ses, annars ej bedömbär.

### När?

Patient över 50 år med buk-, flank- eller ryggsmärta, synkope eller chock. Hjärtstopp. Arteriell insufficiens i benen. Bifynd vid annan bukundersökning.

**Spära:** proximalt tvärsnitt med truncus/SMA, största AP-mått, bifurkationen, längsaxel.